

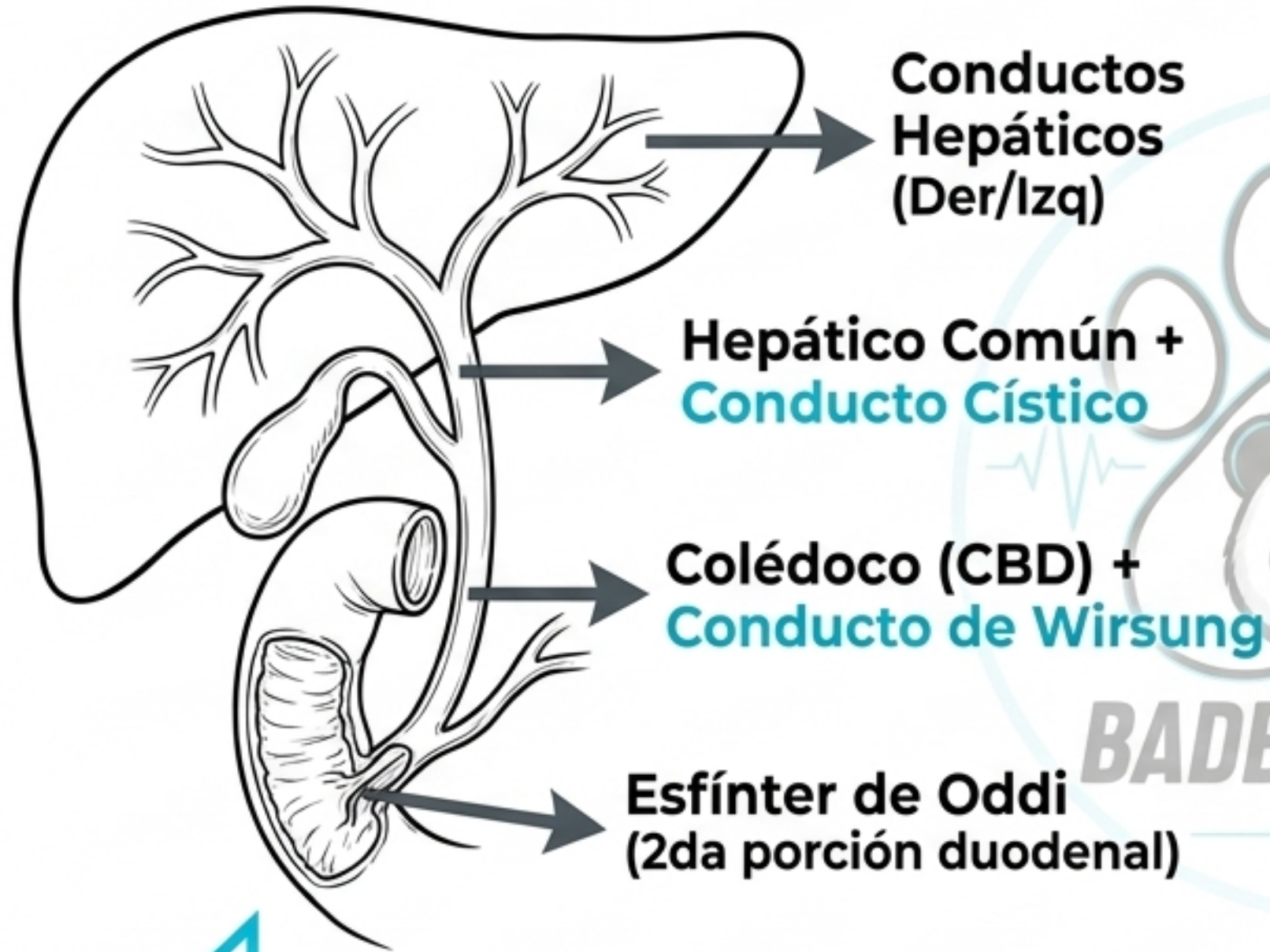


PROPT/LOGÍA OVES PAT /VEDEA: PATOLOGÍA QUIRÚRGICA BENIGNA Y MALIGNA DE VESÍCULA Y VÍAS BILIARES

Guía Estructural de Estudio Completo (High-Yield)

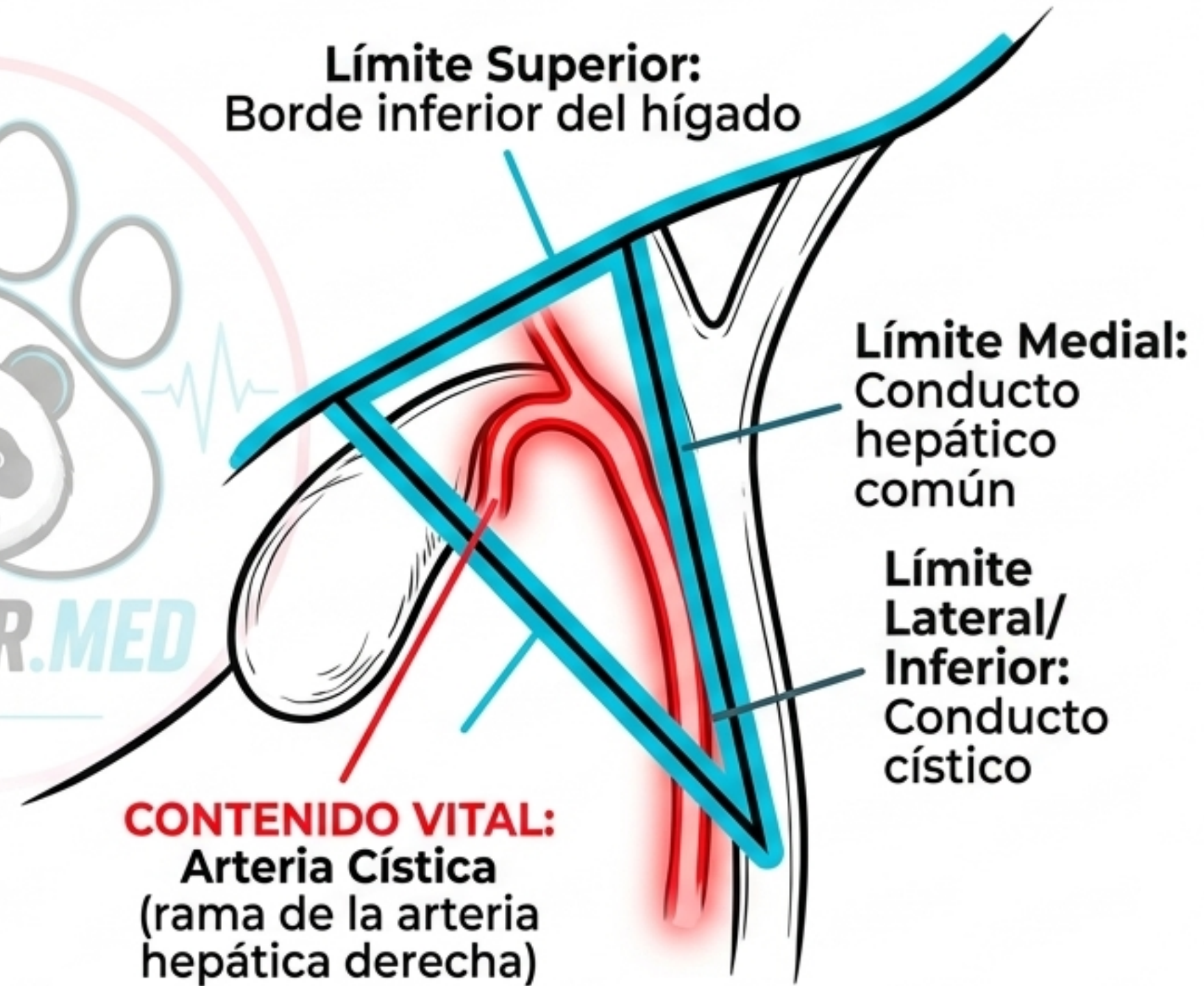
Síguenos en: Facebook | Instagram | YouTube | Rutube | Only Fans | Telegram | TikTok

Fisiología y Vía Biliar



Dato Clave: Producción diaria de bilis = 600 - 1000 cc.

Reparo Quirúrgico Crítico: Triángulo de Calot



Colelitiasis y Cólico Biliar (La Génesis)

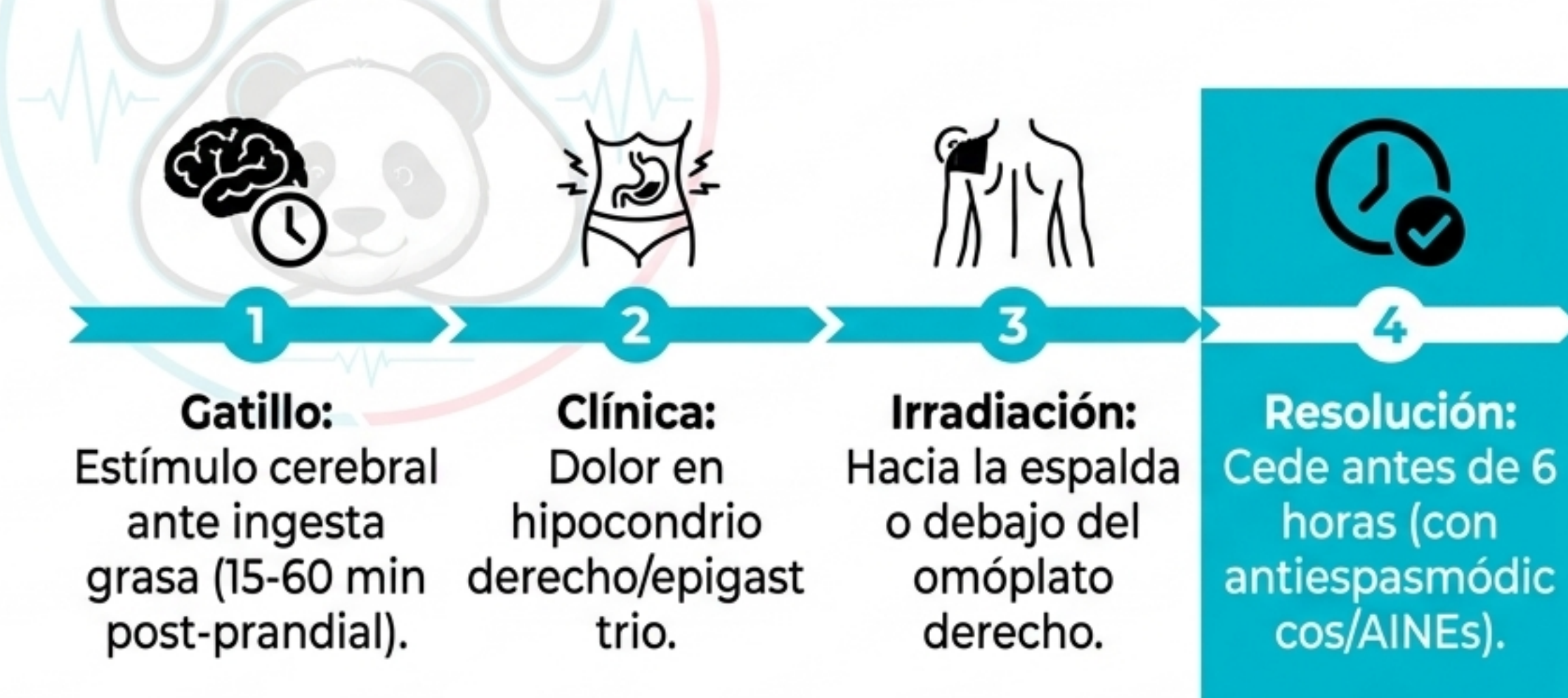
- **Definición:** 80% cálculos de colesterol + ácidos biliares/lecitina.
50% asintomáticos.



Epidemiología: Las 4 Fs

 Femenino (Mujer)	 Fat (Sobrepeso)
 Forty (Edad media)	 Fertilidad (Hijos)

El Cólico Biliar (Obstrucción Transitoria)



Colecistitis Aguda: Fisiopatología y Clínica

Cascada Fisiopatológica

Obstrucción del cístico por cálculo
+ Irritación por sales biliares

Dstrucción de la mucosa y
distensión vesicular

Aumento de presión intraluminal

Obstrucción venosa y del drenaje linfático

ISQUEMIA → NECROSIS → PERFORACIÓN

Clínica Crítica

- Dolor continuo > 6 horas.
- **Signo de Murphy (+):** Cese de la inspiración a la palpación profunda en HD.
- **Fiebre, náuseas,** masa palpable dolorosa.



Ecografía (Gold Standard)

Hallazgos: Engrosamiento de pared > 4 mm, líquido pericolecístico, sombra acústica.

Matriz de Gravedad (Criterios de Tokyo 2018)

Grado I (Leve)	Grado II (Moderado)	Grado III (Severo - Falla Orgánica)
• Sin disfunción de órganos. • Cambios inflamatorios leves. • Colelap segura.	• Leucocitos > 18,000/mm³. • Masa palpable en HD. • Síntomas > 72 horas. • Inflamación local marcada (gangrenosa, enfisematosa, absceso, peritonitis biliar).	• Cardiovascular: Hipotensión (requiere dopamina/norepinefrina). • Neurológica: Alteración del nivel de conciencia. • Respiratoria: PaO₂/FiO₂ < 300. • Renal: Creatinina > 2.0 mg/dl. • Hepática: INR > 1.5. • Hematológica: Plaquetas < 100,000.

Abordaje Quirúrgico y Complicaciones

Manejo Quirúrgico

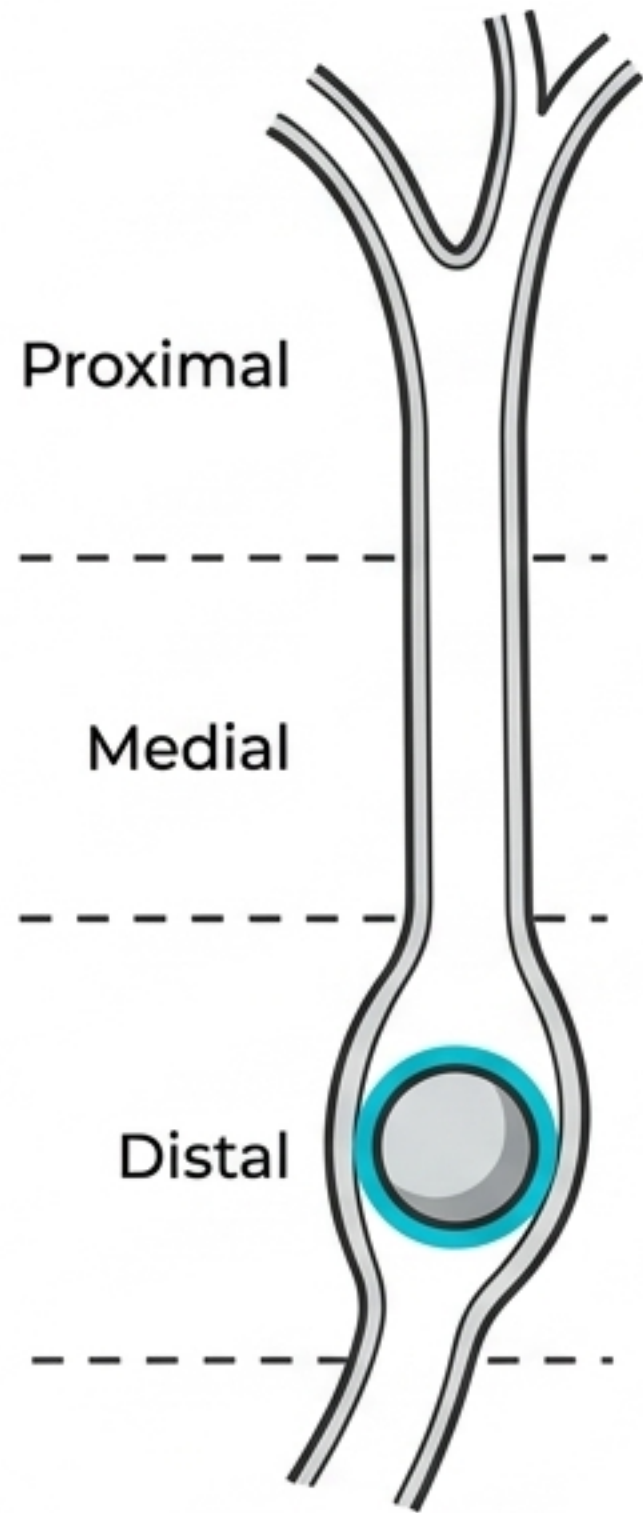
Motivos de Conversión a Abierta (20%)

- ✓ **Colecistectomía Laparoscópica (Colelap):** De elección. Ideal dentro de las primeras 72 horas.
 - ✓ **Colecistostomía:** Drenaje percutáneo del fondo vesicular. Reservado para ancianos inestables o ASA III/IV. Cirugía diferida a 3-6 meses.
- ⚠ Adherencias severas / anatomía del Calot irreconocible.
 - ⚠ Sangrado incontrolable.
 - ⚠ Sospecha de lesión de vía biliar.
 - ⚠ Caída de múltiples cálculos a cavidad.



ALERTA DE COMPLICACIONES: Empiema vesicular, fístula colecistoduodenal, íleo biliar, peritonitis libre.

Coledocolitiasis (El Cálculo Migratorio)



**REGLA
HEMODINÁMICA:
¡Todo lo que está
por encima de una
obstrucción se
dilata!**

Concepto

Cálculo en la vía biliar principal (8-20% de pacientes con coledocolitiasis).

Clínica Obstructiva

Ictericia franca, **coluria** (orina oscura), **hipocolia** (heces claras). Riesgo de **pancreatitis** aguda biliar.

Diagnóstico Escalonado

1. Ecografía:

Detecta dilatación del colédoco (> 6mm).

2. Colangiografía (CRM):

Mapa anatómico exacto, no invasivo.

3. CPRE (ERCP):

Gold Standard terapéutico (Extracción).

Colangitis Aguda (Infección Bacteriana Letal)

Retención biliar mecánica + Infección (E. coli #1, Klebsiella #2)

Triada de Charcot

[DOLOR EN H.D.] + [ICTERICIA] + [FIEBRE / ESCALOFRÍOS] = COLANGITIS

Pentada de Reynolds

[TRIADA DE CHARCOT] + [CONFUSIÓN MENTAL] + [SHOCK / HIPOTENSIÓN] = SEPSIS GRAVE BILIAR

Manejo de Urgencia

NPO, fluidos IV, **Cefalosporina 3ra Gen (Ceftriaxona) + Metronidazol**. Drenaje biliar urgente (CPRE o percutáneo).

Manejo Intervencionista Biliar

1. CPRE (Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica)

Endoscopia → Esfinterotomía de Oddi → Extracción con canastilla de Dormia.

Riesgos: Hemorragia, Pancreatitis post-CPRE, perforación duodenal.

Endoscopia

2. CTPH (Colangiografía Transhepática Percutánea)

Drenaje guiado por ecografía a través del hígado. Ideal para estenosis altas o intrahepáticas donde la CPRE no llega.

Fluoroscopia

3. Tubo en 'T' (Sonda Kehr)

Drenaje externo tras coledocotomía abierta. Mantiene la vía descomprimida, permite control radiológico (Colangiografía trans-Kehr) y extracción diferida (4-6 semanas).

Radiografía

Lesiones Premalignas (Pólipos vs. Cálculos)

Diferenciación Ecográfica Crítica

Cálculo (Colelitiasis)

- **SÍ** deja sombra acústica.
- **SÍ** es móvil con los cambios de postura.

Pólipo Vesicular

- **NO** deja sombra acústica.
- **NO** es móvil (adherido a la pared).

Vesícula en Porcelana: Calcificación total de la pared por inflamación crónica. Factor de altísimo riesgo carcinogénico → Requiere colecistectomía profiláctica.

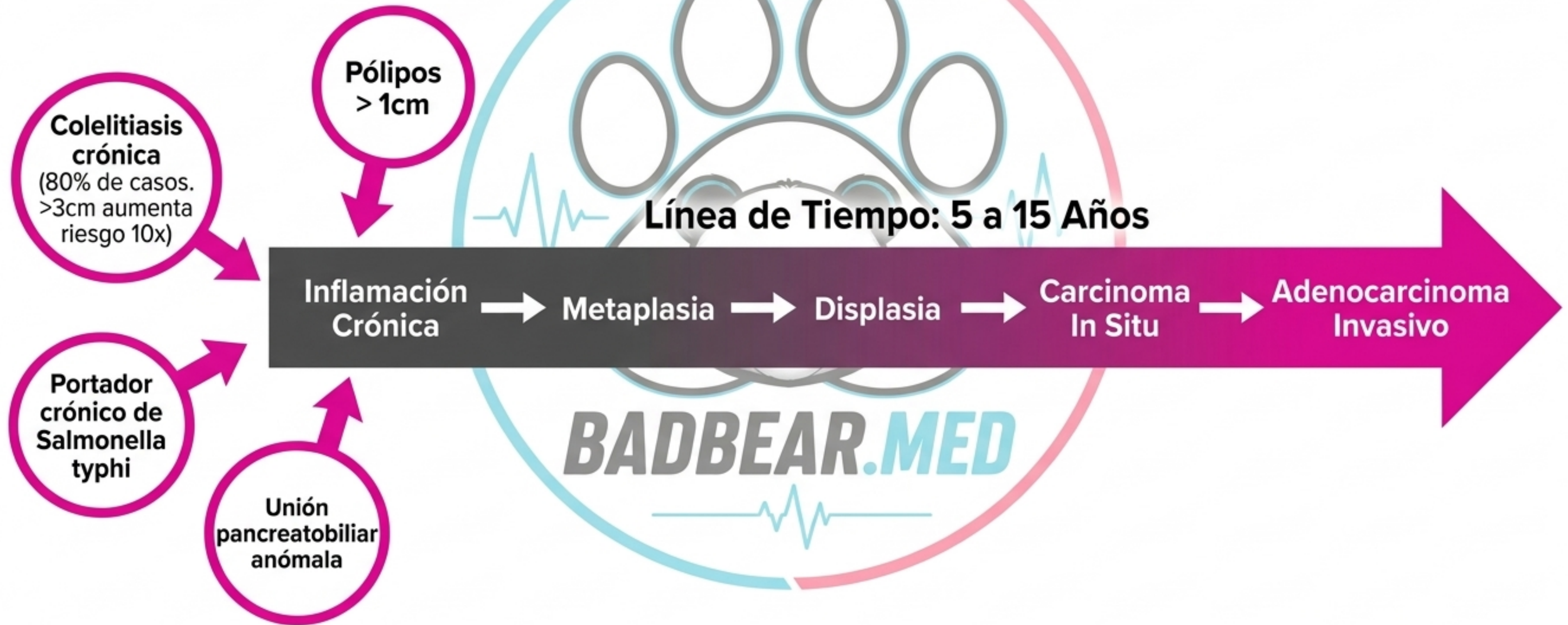
Criterios de Malignidad en Pólipos

- ✓ **Tamaño** > 10 mm (1 cm).
- ✓ **Crecimiento rápido** comprobado.
- ✓ **Base sésil** (ancha).
- ✓ **Edad del paciente** > 60 años.
- ✓ **Pólipo ÚNICO** (los múltiples suelen ser colesterosis benigna / vesícula en fresa).

Cáncer de Vesícula Biliar (El Enemigo Silencioso)

Neoplasia maligna más frecuente del tracto biliar. Relación Mujer:Hombre (3:1).

Localización: Fondo (60%), Cuerpo (30%), Cuello (10%).



Clínica, Diagnóstico y Manejo del Cáncer

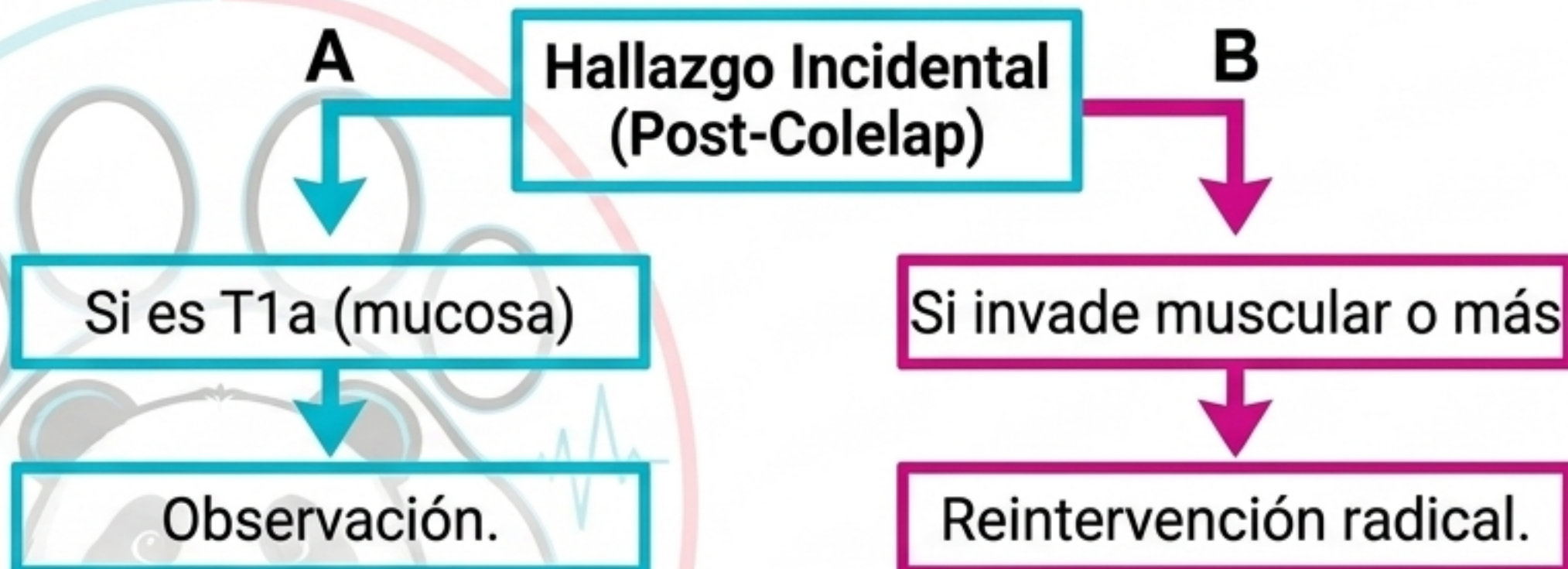
Clínica Avanzada

- **Signo de Courvoisier-Terrier:** Vesícula palpable NO dolorosa + Ictericia.
- **Baja de peso** masiva, anorexia (diagnóstico tardío).

Diagnóstico por Imagen

TAC Trifásico Hepático
(engrosamiento asimétrico de pared, invasión a parénquima).

Algoritmo de Manejo Quirúrgico



Cirugía Curativa (Colecistectomía Radical):

- Resección vesicular en bloque
- Bisegmentectomía hepática (Segmentos IVb y V)
- Linfadenectomía del pedículo portal y ganglio de Mascagni.

Criterio de Irresecabilidad: Ganglios intercavaoárticos positivos.

Colangiocarcinoma y Tumor de Klatskin

Adenocarcinoma ductal. Clínica: Ictericia profunda ("pacientes verdes"), prurito intratable.

Clasificación de Bismuth-Corlette

Tipo IIIa:

Confluencia + Invasión del conducto hepático Derecho.

Tipo II:

El tumor involucra la confluencia hepática (Carina).

Tipo I:

Tumor limitado al conducto hepático común (por debajo de la confluencia).

Tipo IIIb:

Confluencia + Invasión del conducto hepático Izquierdo.

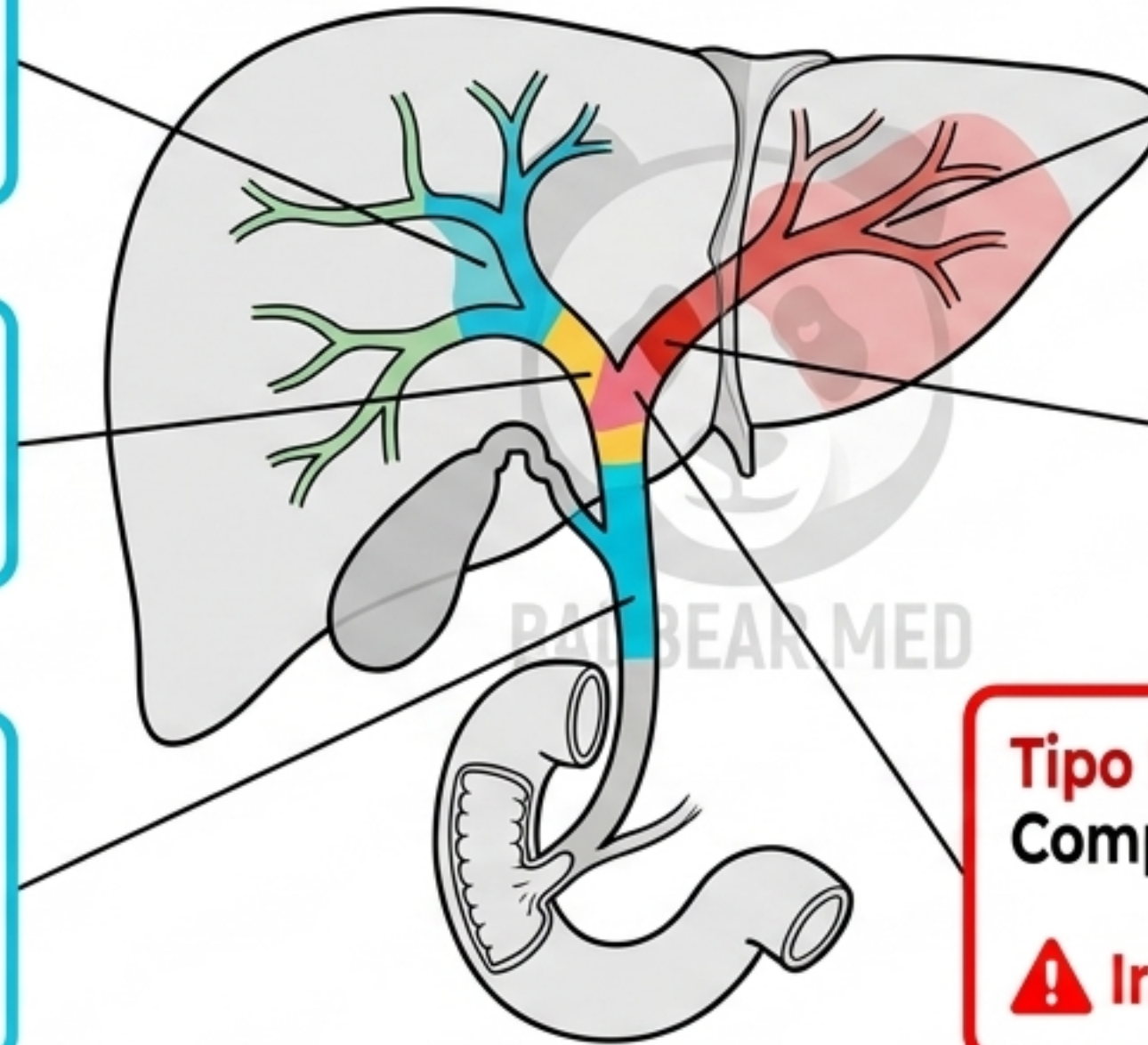
Tipo IIIa:

Confluencia + Invasión del conducto hepático Izquierdo.

Tipo IV:

Compromiso bilateral o multifocal.

⚠ Irresecable → Paliación o trasplante



Matriz de Síntesis Clínica (Diagnóstico Diferencial)

Patología	Síntoma Dominante	Examen Físico	Laboratorio Clave	Ecografía/TAC	Tratamiento Inicial
Cólico Biliar	Dolor < 6h post-prandial	Sin Ictericia, Sin Fiebre	Normal	Piedras, pared fina	Antiespasmódicos, Colelap electiva
Colecistitis Aguda	Dolor > 6h	Murphy (+), Fiebre	Leucocitosis	Pared >4mm, líquido	ATB, Colelap urgente (<72h)
Coledocolitiasis	Dolor variable	Ictericia Franca	Bilirrubina Directa ↑, FA ↑	Colédoco > 6mm dilatado	CPRE, luego Colelap
Colangitis Aguda	Dolor + Ictericia	Fiebre alta (Charcot)	Leucocitosis, Bilirrubina ↑↑	Colédoco dilatado	Drenaje urgente (CPRE)
Cáncer Vesicular	Pérdida de peso	Courvoisier (+), Ictericia tardía	CA 19-9 ↑	Masa, invasión local	Cirugía radical + Bisegmentectomía

ESTUDIO COMPLETO FINALIZADO.

El conocimiento anatómico y **fisiopatológico estructurado salva vidas**. Revisa esta guía clínica las veces que sea necesario para dominar el abdomen agudo biliar.

PROYECTO BADBEAR.MED